

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

YMRS · YOUNG MANIA RATING SCALE

Escala de Young para la Evaluación de la Manía — Patrón oro internacional heteroaplicado para cuantificar la gravedad de episodios maníacos e hipomaníacos

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Young Mania Rating Scale (YMRS)
Nombre en español	Escala de Young para la Evaluación de la Manía
Sigla oficial	YMRS
Autores originales	Robert C. Young, John T. Biggs, Vincent E. Ziegler y David A. Meyer (1978)
Adaptación hispanohablante	Francesc Colom, Eduard Vieta, J. M. Martínez-Arán, E. García-García et al. (2002)
Año de publicación original	1978 (validación española multicéntrica oficial en 2002)
Constructo primario	Severidad sindrómica global del episodio maníaco en el Trastorno Bipolar tipo I y II
Formato de administración	Heteroaplicada mediante entrevista clínica semiestructurada y observación conductual directa
Población diana	Pacientes adultos y adolescentes con sospecha o confirmación de episodio maníaco o hipomaníaco
Tiempo de aplicación	15 a 20 minutos (11 ítems con ponderación clínica específica)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de dominio público con fines asistenciales y académicos

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Young Mania Rating Scale** (YMRS) es el patrón oro (**gold standard**) universal para la cuantificación de la gravedad de los estados de manía y la monitorización de la eficacia de fármacos estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos. Diseñada por Robert C. Young y su equipo en la Washington University School of Medicine (St. Louis), la escala fue construida para superar la subjetividad y falta de colaboración típica del paciente maníaco, quien suele carecer de conciencia de enfermedad y tender a la minimización en escalas autoaplicadas.

El diseño psicométrico de la YMRS presenta una particularidad metodológica clave: combina la información verbal referida por el paciente durante las últimas 48 horas con la **observación conductual directa** del clínico durante la entrevista. Consta de 11 ítems, cuatro de los cuales (**Irritabilidad**, **Expresión verbal**, **Contenido del pensamiento** y **Conducta agresiva/disruptiva**) reciben una ponderación doble (puntuándose de 0 a 8 en lugar de 0 a 4) para compensar la falta de insight del paciente y calibrar adecuadamente los síntomas nucleares de máxima repercusión médica y pericial. La validación española del grupo de Trastornos Bipolares del Hospital Clínic de Barcelona (Colom, Vieta et al., 2002) confirmó su excelente fiabilidad y sensibilidad al cambio.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Ítem / Dimensión YMRS	Ponderación	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización Semiográfica
1. Estado de Ánimo Elevado	Escala simple	0 – 4	Optimismo leve a euforia delirante con risa incontinente y júbilo expansivo.
2. Aumento Energía / Actividad Motora	Escala simple	0 – 4	Vitalidad incrementada a agitación motora continua e hiperactividad errática.
3. Interés Sexual	Escala simple	0 – 4	Discreto aumento a hipersexualidad desinhibida o conductas sexuales obscenas.
4. Sueño	Escala simple	0 – 4	Disminución de 1 hora a privación absoluta sin sensación de cansancio.
5. Irritabilidad (*)	Ponderación doble	0 – 8	Subjetiva leve (0) a hostilidad agresiva incontrolada y no cooperadora (8).
6. Expresión Verbal / Habla (*)	Ponderación doble	0 – 8	Locuacidad leve a verborrea atropellada, logorrea incoherente e ininterrumpible (8).
7. Trastornos del Lenguaje / Pensamiento	Escala simple	0 – 4	Circunstancialidad a fuga de ideas, disgregación y pérdida de asociaciones.
8. Contenido del Pensamiento (*)	Ponderación doble	0 – 8	Proyectos ambiciosos a delirios megalomaniacos o de autorreferencia/persecución (8).
9. Agresividad / Conducta Disruptiva (*)	Ponderación doble	0 – 8	Sarcasmo a agresión física real, violencia y destrucción de mobiliario (8).
10. Apariencia	Escala simple	0 – 4	Arreglado a atuendo bizarro, desaliño extremo, maquillaje excesivo y teatral.
11. Conciencia de Enfermedad (Insight)	Escala simple	0 – 4	Reconoce el trastorno a negación absoluta y rechazo de la atención médica.
Puntuación Total YMRS	11 ítems	0 – 60	Suma directa de los 7 ítems simples (0-4) y los 4 ítems ponderados (0-8).

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.88 – 0.91	Excelente fiabilidad en la validación española del Hospital Clínic (Colom et al., 2002).
Fiabilidad interjueces	CCI = 0.93 – 0.96	Concordancia clínica casi perfecta entre evaluadores psiquiátricos entrenados.
Fiabilidad test-retest	r = 0.88 – 0.92 (48 horas)	Alta estabilidad en pacientes maníacos en fase de tratamiento agudo.
Sensibilidad al cambio farmacológico	Effect size d = 1.45	Máxima sensibilidad empírica para cuantificar respuesta a Litio, Valproato y Antipsicóticos.
Criterio Consenso de Remisión	YMRS ≤ 12 puntos	Estándar internacional unánime para definir eutimia o remisión completa.
Criterio Consenso de Respuesta	Reducción ≥ 50% del total	Estándar oficial utilizado por la EMA y la FDA en ensayos clínicos de manía bipolar.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Calificación de Ítems Simples (7 ítems):** Ítems 1, 2, 3, 4, 7, 10 y 11. Se califican de 0 a 4 puntos según descripciones operativas estrictas:
 - **0** = Normal / Ausente; **1** = Leve o cuestionable; **2** = Moderado; **3** = Marcado / Grave; **4** = Extremo o incapacitante.
- **Calificación de Ítems Ponderados (*) (4 ítems):** Ítems 5 (**Irritabilidad**), 6 (**Habla**), 8 (**Contenido del pensamiento**) y 9 (**Agresividad**).
 - Se califican en escala de 5 anclajes con salto de dos puntos: **0, 2, 4, 6 y 8 puntos** (reflejando la duplicación del peso clínico).
- **Puntuación Total YMRS:** Suma directa simple de los 11 ítems (rango posible: 0 a 60 puntos).
- **Fuentes de Información:** El clínico debe integrar el autoinforme del paciente con el informe del personal de enfermería o familiares de las últimas 48 horas.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Estado Clínico Bipolar	Significación Psicopatológica y Criterio Asistencial
0 – 12 puntos	Eutimia / Remisión	Ausencia de síntomas maníacos significativos. Criterio formal de remisión del episodio.
13 – 19 puntos	Hipomanía / Manía Leve	Expansividad o irritabilidad leve. Hiperactividad sin desorganización conductual grave ni psicosis. Manejo ambulatorio.
20 – 25 puntos	Manía Moderada	Aceleración psicomotora manifiesta, verborrea intensa, disminución marcada del sueño. Frecuente necesidad de ingreso hospitalario.
26 – 60 puntos	Manía Grave / Aguda	Urgencia psiquiátrica mayor. Agitación severa, delirios megalomaniacos o de persecución, alto riesgo heteroagresivo o de ruina. Ingreso urgente.

CRITERIOS DE EFICACIA TERAPÉUTICA (COLOM, VIETA ET AL., 2002): 1) **Respuesta Clínica:** Reducción ≥ 50% de la puntuación basal de la YMRS. 2) **Remisión del Episodio Maníaco:** Puntuación final ≤ 12 puntos (en ensayos exigentes ≤ 8 puntos) mantenida durante al menos 2 semanas consecutivas.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Valoración de urgencia e integridad en triaje psiquiátrico:

- Aplicar la YMRS ante cuadros de excitación psicomotora, insomnio de conciliación con hiperactividad, gastos desmedidos o euforia expansiva.

Paso 2: Evaluación de criterios de ingreso inmediato:

- Si YMRS ≥ 26 o si el Ítem 8 = 6 u 8 (delirios de grandeza o psicosis) o el Ítem 9 = 6 u 8 (violencia física/destrucción): Indicación inaplazable de ingreso en Unidad de Hospitalización de Agudos (voluntario o involuntario judicial).

Paso 3: Abordaje psicofarmacológico según la gravedad:

- **YMRS 13 – 19 (Hipomanía):** Ajuste o instauración de estabilizador del ánimo (Litio, Valproato o Lamotrigina) en monoterapia ambulatoria; optimización del descanso con benzodiazepinas.
- **YMRS ≥ 20 (Manía Aguda Moderada a Severa):** Terapia combinada de inicio rápido: Estabilizador del ánimo (Litio a litemias 0.8-1.2 mEq/L o Valproato) asociado a un Antipsicótico Atípico antimaniaco de primera línea (Olanzapina 10-20 mg, Aripiprazol 15-30 mg, Quetiapina 400-800 mg o Risperidona 3-6 mg/día).

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 32 años, profesor de educación secundaria, diagnosticado de Trastorno Bipolar tipo I, traído al hospital por el servicio de urgencias médicas tras ser detenido en un concesionario intentando adquirir tres coches de alta gama asegurando que “el gobierno le ha financiado un proyecto secreto”.

Resultados en la Escala YMRS (Al Ingreso):

- **Puntuación Total Basal: 38 / 60 (Manía Grave).**

- Desglose clínico destacado:

- ▶ Ítem 1 (Ánimo elevado) = 3; Ítem 2 (Energía) = 4 (agitación psicomotora continua).
- ▶ Ítem 4 (Sueño) = 4 (no ha dormido nada en 3 días sin sensación de cansancio).
- ▶ Ítem 5 (Irritabilidad) = 6 (cólera inmediata si se le cuestiona su proyecto).
- ▶ Ítem 6 (Expresión verbal) = 6 (habla torrencial ininterrumpible a gritos).
- ▶ Ítem 7 (Pensamiento) = 3 (fuga de ideas evidente).
- ▶ Ítem 8 (Contenido) = 6 (delirio megalomaniaco místico-político con ruina económica).
- ▶ Ítem 11 (Insight) = 4 (niega enfermedad mental de forma radical).

Manejo Asistencial y Respuesta: Se tramitó ingreso involuntario urgente en Unidad de Agudos de Psiquiatría. Se inició tratamiento con Ácido Valproico 1500 mg/día (valproemia = 85 mcg/ml) asociado a Olanzapina 20 mg/día. A los 7 días de ingreso, la YMRS descendió a 21 puntos (remisión de la agitación motora); a los 18 días, alcanzó 7 puntos (eutimia completa, desaparición del delirio y recuperación del insight), recibiendo el alta para seguimiento ambulatorio en el Programa de Trastorno Bipolar.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE SEGURIDAD CRÍTICA:

- **Agotamiento físico y deshidratación:** En manías extremas (YMRS > 40), la hiperactividad continua sin ingesta de líquidos puede inducir rabdomiólisis o fallo renal agudo.
- **Riesgo de ruina económica y legal:** La desinhibición y grandiosidad generan firmas de préstamos ruinosos o conductas que exigen medidas cautelares de protección patrimonial.
- **Episodios Mixtos:** Si coexisten síntomas depresivos con manía, el riesgo autolítico impulsivo es máximo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Esquizofrenia vs. Manía con síntomas psicóticos:** En la manía los delirios son megalomaniacos congruentes con el júbilo expansivo y la actividad psicomotora es acelerada.
- **Intoxicación por estimulantes (cocaína, anfetaminas):** Realizar cribado toxicológico en orina obligatorio en todo debut maniaco agudo.
- **Manía orgánica secundaria:** Descartar patología tiroidea (tirotoxicosis), neuroinfecciones o lesiones en lóbulo frontal derecho.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Young, R. C., Biggs, J. T., Ziegler, V. E., & Meyer, D. A. (1978). A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. *British Journal of Psychiatry*, 133(5), 429–435. <https://doi.org/10.1192/bjp.133.5.429>
2. Colom, F., Vieta, E., Martínez-Arán, A., García-García, M., Reinares, M., Torrent, C., ... & Gastó, C. (2002). Versión española de una escala de evaluación de la manía: validez y fiabilidad de la Escala de Young. *Medicina Clínica*, 119(10), 366–371. [https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(02\)73419-6](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(02)73419-6)
3. Vieta, E., Berk, M., Wang, P. W., & Tohen, M. (2018). *Managing Bipolar Disorder in Clinical Practice* (3rd ed.). Springer.
4. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.